

[illegible]



HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS

Nome: CARLOS ABERTO ZOPPI
Sexo: M Código: 3547355 Idade: Data:

02/08-24-960



Dr Ricardo - Stano Cin Quis

Paciente: Carlos Alberto Zoppi

Médico(a) solicitante: Dr(a). Flávia K. S. Oliveira

Idade: 66 anos

Data do exame: 06/07/2022

Nº do exame: 35908BT

Peso (Kg) Altura (m) IMC (Kg/Alt²)
95 1,75 31,02

Escala de Sonolência Epworth: 10
Medicamentos: Puran T4, Rosucor, Assertil.

RESULTADOS DOS PARÂMETROS DO SONO

Horário do início do registro: 23:30:13

Horário do término do registro: 06:34:43

Boa noite: 23:31:43

Bom dia: 06:34:19

Tempo Total de Registro (TTR): 424.5 min

Tempo do Período do Sono (TPS): 421.5 min

Tempo Total de Sono (TTS): 402.5 min

ESTÁGIOS DO SONO

	Minutos	%TTS
Estágio 1	24.0	6.0
Estágio 2	155.0	38.5
Sono de ondas lentas	98.5	24.5
Sono REM	125.0	31.1
Vigília	19.0	

LATÊNCIAS

Latência do início do Sono: 0.0 min.

Latência de Sono REM (do início do sono): 25.5 min.

CONTINUIDADE DO SONO

Número de microdespertares: 62

Número de despertares: 0

Índice de microdespertar: 8.8

Eficiência de sono: 95.2%

MOVIMENTOS PERIÓDICOS

Tipo de movimentos	Nº Total de movimentos	Índice
Isolados	15	2.1
Periódicos		
Isolados c/ microdespertar	11	1.6
Periódicos c/ microdespertar		

Conclusões:

Técnica "Split-Night" utilizada de acordo com: (The impact of Split-Night Polysomnography – Sanders et al. *Sleep*, Vol. 23, nº1, 2000.)

1. Eficiência da sono adequada (95.2%);
2. Latência para o sono reduzida (0.0)min.;
3. Proporção de sono de ondas lentas adequada (24.5%);
4. Proporção de sono REM aumentada (31.1 %);
5. Latência para o sono REM reduzida (25.5 min.);
6. Índice de apnéia + hipopnéia moderadamente elevado na 1ª fase do exame (20.9 eventos/hora), onde os eventos respiratórios obstrutivos dos tipos apnéia e hipopnéia ocorreram nos períodos de decúbito dorsal e decúbito lateral, resultando em: (A) - Dessaturação leve da oxi-hemoglobina, permanecendo 2.2% menor que 90% e saturação basal de 92%. (B) - Ronco leve a moderado e contínuo. (C) - Fragmentação do sono devido a aumento de macro e micro-despertares. (D) - Aumento dos movimentos de membros;
7. Discreta elevação da frequência de eventos respiratórios não apneicos, não hipopneicos, decorrentes a elevação da resistência de vias aéreas superiores, resultando em períodos de ronco contínuo e/ou crescente culminando com micro-despertares e fragmentação do sono, sem no entanto, alterar significativamente saturação da oxi-hemoglobina, foram observados durante todos os decúbitos;
8. Respiração bucal mesclada a nasal durante a 1ª fase do exame;
9. Após o início do CPAP (2ª fase do exame) e ajuste da pressão do mesmo no transcorrer da noite, observou-se tendência em reversão dos fenômenos descritos nos parágrafos acima.

OBS: A máscara que mais se adequou foi uma nasal Eson 2 M (Fisher&Paykel).

Comentários:

Comentários:
Síndrome da Apnéia e Hipopnéia do Sono de moderada intensidade, resultando em fragmentação do sono e dessaturação leve da oxi-hemoglobina + Síndrome do Aumento da Resistência de Vias Aéreas Superiores discreta, resultando em fragmentação do sono, ambas responsivas ao tratamento com CPAP regulado com pressão de 6,0 cm de H₂O.

Dr. Maurício da Cunha Bagnato CRM – 60446

Responsável pela Medicina do Sono HSL

Vide gráficos e exemplos abaixo

DE MAURICIO BAGNATO
CRM 60446